

NEUMOPERITONEO. PERFORACIÓN VÍSCERA HUECA.

Blanca Amada de Urrutia y Nadal

INTRODUCCIÓN

El interés que supone el neumoperitoneo como signo clínico se basa en la frecuencia con la que nos encontramos en la práctica clínica diaria su causa principal, la perforación de víscera hueca (supone el 90% de los neumoperitoneos y la gran mayoría -hasta el 90%- requerirá un abordaje quirúrgico). La perforación de víscera hueca es responsable de hasta un 5-10% de las causas de abdomen agudo, con el impacto que esto tiene en la asistencia hospitalaria urgente y en tasas de morbi-mortalidad secundaria.

Una adecuada aproximación en el Servicio de Urgencias, mostrando un alto índice de sospecha y basado en conocimientos anatómicos, fisiológicos y microbiológicos permitirán el diagnóstico y tratamiento precoz, con disminución de complicaciones derivadas.

INFLAMATORIO	INFLAMATORIO	INFLAMATORIO
Perforación visceral o por cuerpo extraño	Obstrucción intestinal	Hemorragia intraperitoneal
Peritonitis primaria	Obstrucción biliar	Isquemia (trombosis/embolismo mesentérico)
Gastroenterocolitis	Torsión epiploica	Infarto esplénico
Enfermedad inflamatoria intestinal	Ginecológico	
Ginecológico		
Diverticulitis de Meckel		
Pancreatitis		
Absceso hepático / esplénico		
Linfadenitis mesentérica		
Uro-Ginecológico		

Diagnóstico diferencial abdomen agudo

DIAGNÓSTICO

Antes de entrar en profundidad en la aproximación diagnóstica, resulta interesante clasificar los tipos de dolor que nos orientarán en la práctica diaria.

- Dolor visceral: Secundario a contracción o espasmo visceral con estimulación de estructuras nerviosas aferentes. Este dolor se referirá en la línea media, a distinta altura (epigastrio, mesogastrio o hipogastrio) según el origen embrionario de las vísceras intraabdominales afectadas.
- Dolor parietal: Secundaria a irritación peritoneal directa.
- Dolor referido: Percibido en una zona alejada del lugar donde se localiza el proceso patológico.

Intestino Proximal	3ª porción duodenal a 2/3 colon transversal	Epigastrio
Intestino Medio	3ª porción duodenal a 2/3 colon transversal	Mesogastrio
Intestino distal	Último tercio colon transversal a recto	Hipogastrio

A continuación, desarrollamos de forma esquemática la aproximación diagnóstica del proceso que nos ocupa.

Antecedentes médico-quirúrgicos generales.

Mostrando interés en los antecedentes de cirugía previa abdominal, tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o quimioterapia, así como antecedentes de úlcera gastroduodenal previa o enfermedad diverticular.

DOLOR	SÍNTOMA GUÍA
Localización	Localizado / Difuso
Inicio	Súbito / Progresivo
Duración	Horas / Días; Continuo / Discontinuo
Características	Urente / Agudo / Desgarrante / Opresor / Sordo
Factores modificadores	de alivio o exacerbadores

Anamnesis.

El síntoma que referirá el paciente y por el que nosotros debemos atender como guía es el **dolor**.

DOLOR	SÍNTOMA GUÍA
Localización	Localizado / Difuso
Inicio	Súbito / Progresivo
Duración	Horas / Días; Continuo / Discontinuo
Características	Urente / Agudo / Desgarrante / Opresor / Sordo
Factores modificadores	De alivio o exacerbadores

Interrogaremos sobre su localización (si es difuso o localizado y de ser localizado, el cuadrante/s dónde lo ubica - se le puede pedir que lo señale con el dedo-), inicio (súbito o progresivo/gradual), duración (tiempo de evolución, horas, días y si es continuo/discontinuo), características (sordo, urente, desgarrante, opresor) y por último factores modificadores, tanto de mejoría como exacerbadores (movimiento, ingesta alimentaria).

Preguntaremos también sobre otros síntomas asociados: fiebre o sensación distémica; Náuseas o vómitos; Síncopa asociado al inicio del dolor.

Exploración física.

La realizaremos de forma sistemática y a poder ser, siempre en el mismo orden de cara a evitar que se nos olviden algunos aspectos de la misma.

Valoración del estado general: Con la simple inspección valoraremos si nos impresiona de gravedad por un mal o regular **estado general** o por el contrario el aspecto de inicio es bueno.

Aquí podremos detenernos y valorar si adquiere **posturas antiálgicas**, la **coloración e hidratación cutáneo-mucosa**, que nos podrá orientar a situaciones de deshidratación aguda o mala perfusión periférica y valorar el **Glasgow**, alterado en procesos que cursen con shock.

Constantes vitales: Nos interesa identificar de forma precoz aquellos pacientes que puedan encontrarse en situación de inestabilidad hemodinámica establecida o con riesgo de establecerse en un breve periodo de tiempo, ya que esto podrá determinar que no sea posible realizar determinadas pruebas complementarias o requieran la valoración por la Unidad de Cuidados Intensivos.

Determinaremos: **Temperatura** (Atención a la hipotermia, puede ser síntoma de shock), **tensión arterial**, **frecuencia cardíaca**, **frecuencia respiratoria** y **saturación periférica de oxígeno**.

Exploración abdominal: Prestaremos atención a los siguientes puntos.

- Observación / Inspección: Aspecto general del mismo (hundido, distendido a tensión o no) y movimiento en relación con la respiración (movimiento paradójico, limitado...)
- Auscultación. Identificación de ruidos peristálticos y sus características: Si están **ausentes** puede ser secundario a una peritonitis establecida o íleo; si están aumentados, puede ser secundario a un patrón obstructivo.
- Palpación y Percusión*: Valoraremos la presencia de **defensa abdominal localizada o generalizada** (signo de irritación peritoneal subyacente) iniciando la exploración lejos del punto de máximo dolor señalado por el paciente*.
- Es importante determinar si la presencia de defensa abdominal es de origen involuntario (irritación peritoneal) o de origen voluntario (ansiedad). Una manera para determinarlo es pidiendo al paciente que flexione las piernas; en caso de defensa abdominal involuntaria, seguirá manifestándose en esta posición.

Igualmente es importante explorar las regiones inguino-crurales y umbilical a descartar la presencia de hernias.

Pruebas complementarias.

- Hemograma con recuento y fórmula leucocitaria.
- Bioquímica glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOP, GPT, LDH, bilirrubina, lipasa, amilasa, PCR, procalcitonina, fibrinogeno.
- Coagulación.
- Sistemático y sedimento de orina con amilasuria.
- Gasometría arterial que nos determine pH y exceso de bases.
- Radiografía de Tórax. La radiografía de tórax en bipedestación y en una proyección posteroanterior, es la **prueba de elección** para determinar la existencia de neumoperitoneo.
- Radiografía de Abdomen. Segunda prueba de elección si el tórax no es factible, habrá que realizarla en decúbito lateral izquierdo y con rayo horizontal.
- TC Abdómino-Pélvico. Con una alta sensibilidad (entre el 85-100%) nos podrá identificar neumoperitoneo y otros signos directos o indirectos de perforación de víscera hueca. El paciente deberá encontrarse **estable hemodinámicamente** para poder realizarse la prueba en condiciones de seguridad.

Aire subdiafragmático derecho	Signo radiológico más frecuente
Signo de Rigler o de la doble pared intestinal	Visualización de la pared intestinal por contraste con el aire extraluminal en disposición interesas.
	

TRATAMIENTO

Interesa llegar a un diagnóstico diferencial precoz con intención de no demorar el inicio de tratamiento. Esquemáticamente la aproximación terapéutica en Urgencias consistirá en los siguientes apartados.

- Dieta. Mantendremos al paciente en dieta absoluta.
- Monitorización. Tendremos en la medida de lo posible al paciente monitorizado, atendiendo a posibles alteraciones de constantes que requieran reajuste de tratamiento o revalorización de la situación clínica.
- ECG con tira de ritmo.
- Acceso venoso periférico. Si hipotensión dos accesos venosos de grueso calibre.
- Oxigenoterapia: el objetivo es $\text{SatO}_2 > 94\%$ dependiendo de patología asociada, administraremos O_2 2LX' endonasal o VTM28% 4LX' según clínica del paciente.
- Fluidoterapia. Iniciaremos la infusión de cristaloides de forma precoz, basándonos en la estimación de pérdidas y teniendo en cuenta posibles comorbilidades concomitantes (insuficiencia cardíaca, por ejemplo)
- Sondaje vesical. Interesa el control de la diuresis, como orientación sobre el estado de perfusión tisular y detección precoz de estados de sepsis/shock, así como para el reajuste del aporte de líquidos.
- Tratamiento específico. Solicitaremos valoración al cirujano general de guardia que decidirá la actitud terapéutica a seguir (quirúrgica o no)
- Antibioterapia. Iniciaremos una terapia preoperatoria antibiótica de amplio espectro de acuerdo a los protocolos de cada centro que tengan en cuenta resistencias específicas, las posibles alergias o intolerancias del paciente, así como comorbilidades preexistentes. Posteriormente según resultados de la exploración quirúrgica o resultado de cultivos microbiológicos, dirigiremos la pauta antibiótica.

BIBLIOGRAFÍA

- Langel JT, Mulvihill SJ. Gastrointestinal perforation and the acute abdomen. Med Clin North Am. 2008;92(3): 599-625.
- Moreno Antón F, García-Donas J. Neumoperitoneo no quirúrgico. Rev Clin Esp. 2004;204(7):372-4.
- Basterrechea Iriarte F. Neumoperitoneo hallazgos en radiología simple. Póster nº S-0788. Póster presentado en: SERAM 2012. XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica; 25-28 mayo 2012; Granada, España.